

17 - Hématome retro placentaire - Pr. FAKHIR

Ça va? Vous êtes très peu nombreux. Ça se passe bien pour la gynécologie? Oui? Bien. Alors, il me reste avec vous, pour ma part, trois séances.

On va faire aujourd'hui, je pense, jeudi, et puis la semaine prochaine, mercredi encore. D'accord? Pour faire un certain nombre de chapitres rapidement. Aujourd'hui, on va faire l'hématome rétroplacentaire, et après, on parlera rapidement de la mortalité maternelle, qui est un chapitre juste pour vous permettre d'avoir des définitions concernant la mortalité maternelle, mais aussi pour avoir une idée sur la place de l'obstétrique dans le système de santé.

D'accord? Alors, pour parler de l'hématome rétroplacentaire, cela suppose que vous avez déjà étudié l'après-eclampsie, qui est l'une des étiologies les plus fréquentes de l'hématome rétroplacentaire. Il faut savoir par rapport à la définition, on l'appelle hématome rétroplacentaire ou abréviation en HRP, ou encore on peut l'appeler décollement prématuré d'un placenta normalement inséré, c'est-à-dire DPPN. D'accord? Remarquez qu'ici, il y a plusieurs éléments qui sont importants dans la définition.

C'est un décollement. Un décollement de quoi? Du placenta. D'accord? C'est un décollement qui se fait prématurément parce qu'habituellement, quand est-ce que le décollement placentaire se fait? À la délivrance, au moment de la délivrance, c'est-à-dire après l'accouchement.

Or ici, ça va être un décollement prématuré, c'est-à-dire que l'accouchement n'est pas encore fait. Le fœtus est encore in utero. Et puis, il y a une particularité, c'est que ce placenta, il est normalement inséré.

Pourquoi on va préciser ça? Pour le différencier de ce qu'on appelle un hématome marginal qui est dû au décollement du placenta qui n'est pas inséré. Et là, le pronostic n'est pas le même. Les causes ne sont pas les mêmes.

Bien évidemment, la prise en charge n'est pas du tout la même. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Un hématome, qui dit hématome, c'est une hémorragie, qui va siéger où? Derrière le placenta. C'est-à-dire entre la face maternelle du placenta et la paroi utérine ou l'endomètre.

D'accord? Puis, c'est un hématome et c'est une hémorragie qui va être souvent non extériorisée. Et ça, c'est un élément de danger. Parce que quand l'hémorragie est totalement extériorisée, ça va nous permettre de faire quoi? D'avoir un diagnostic précoce, de quantifier, c'est-à-dire un diagnostic de la gravité ou de la sévérité de l'hémorragie.

C'est-à-dire qu'on va, comme pour le placenta prévia, c'est un saignement qui est totalement extériorisé. Donc, on arrive facilement à le voir et on arrive facilement à déterminer la sévérité du saignement et donc on va agir de plus en plus vite. Alors, dans l'hématome rétro-placenta, ce que ça va se faire derrière le placenta, c'est une renceinte qui est fermée.

Donc, le saignement va rester là et on peut avoir un petit filament de saignement noirâtre, mais qui est minime et qui n'a aucune proportionnalité par rapport à l'importance de l'hématome lui-même. Et donc, ça, ça peut cacher, comme vous avez dit, ça peut cacher le diagnostic un bon bout de temps. Mais en même temps, la gravité de l'hématome rétro-placentaire, c'est que plus on tarde dans le diagnostic et dans la prise en charge, plus ça va être plus grave après.

Et puis, en général, c'est toujours dans la définition, il est secondaire à une désinsertion accidentelle d'une partie ou la totalité du placenta qui est normalement inservie. Et puis, ça peut survenir au cours de la grossesse, c'est-à-dire en dehors de la période du travail ou au cours du travail. Mais le plus important, c'est qu'avant le moment de la délivrance et donc c'est un décollement prématuré d'un placenta normalement inservi.

Donc ça, c'était pour la définition. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend, tout ça ? C'est qu'on est devant une extrême urgence obstétrique. Ça va être une urgence à la fois maternelle, mais aussi fatale.

Et on va comprendre pourquoi. Et puis, elle est imprévisible, puisque vous comprenez que c'est caché, donc on ne connaît pas l'intensité du saignement, donc on ne connaît pas comment ça va, c'est-à-dire quelle est la sévérité, mais aussi on ne sait jamais, en général, quand est-ce qu'un hématome intraplacentaire va survenir. Il peut survenir de façon imprévisible à n'importe quel moment.

C'est un accident grave pour la mère et pour le fœtus. Et puis, si on réfléchit logiquement, on va comprendre très facilement que c'est grave pour le fœtus, parce que qu'est-ce qui se passe ? Si le placenta se décolle, c'est qu'il n'y a plus des échanges, il n'y a plus d'échanges entre le fœtus et la maman, entre, on va dire, le placenta et la perfusion utérine. Et donc, il va y avoir une interruption des échanges qui va facilement entraîner une souffrance fœtale aiguë et dont l'intensité va être proportionnelle à la surface de décollement.

Si c'est une petite surface, ça va, il y a le reste qui est encore fonctionnel, on peut même ne pas le sentir, cet hématome. Mais si c'est un hématome qui est large, où la surface décollée du placenta est importante, parfois ça peut être la totalité du placenta, eh bien, à ce moment-là, ça va être dangereux pour le fœtus parce qu'il va tomber dans une asphyxie et donc on peut avoir, par conséquent, la mort fœtale in utero. D'accord ? Et puis, deuxièmement, la gravité se fait dans l'hémorragie maternelle.

Et on va voir que ça ne va pas être une hémorragie tout court, mais ça va être une hémorragie qui va se compliquer encore si on ne la traite pas rapidement, par des problèmes encore plus sérieux et qui peuvent donner une mortalité maternelle. Donc, par définition, hématome rétro-placentaire risque de mortalité maternelle et fœtale. Et donc, c'est très grave.

C'est une anti. Je ne sais pas si vous avez étudié la GU ? Oui. Donc, on vous dit que la GU, c'est

grave.

C'est aussi un risque de mortalité et quand vous avez un certain nombre de symptômes, c'est une GU jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, pour l'hématome rétro-placentaire, c'est aussi important à s'en rappeler devant un certain nombre de signes. C'est le plus grave de ces signes-là, et on va voir lesquels.

Et donc, on doit y penser à chaque fois. Et bien évidemment, il va y avoir besoin de prise en charge multidisciplinaire. Minimum, c'est un obstétricien, un néonate et un réanimateur.

Et si ça tourne mal, ou si on est dans un contexte de prééclampsie sévère, on sait qu'on peut avoir besoin de beaucoup d'autres choses, notamment une hospitalisation en réanimation maternelle. C'est des femmes qui peuvent avoir des insuffisances rénales. On peut avoir besoin de faire des dialyses.

C'est des enfants qui peuvent avoir des souffrances chroniques. Donc, ils vont être hospitalisés dans une unité néonatale, etc. On peut avoir besoin de transfusion, de transfusion de sang, de plaquettes, de PFC, etc.

Et donc, c'est toute une prise en charge particulière qui devrait se faire dans un centre hospitalier, en général niveau 3, d'accord, pour que tous les risques puissent être gérés. Et puis, biologiquement parlons, il faut savoir que ça peut survenir entre 0,25% jusqu'à 2,5% des grossesses. Ce n'est pas, ce n'est pas, c'est quand même consistant, 2,5%.

Et puis, dans les pré-éclampsies, c'est à peu près 4% des pré-éclampsies, surtout les pré-éclampsies sévères, peuvent avoir un HRP. Alors, sur Marrakech, et ça je pense que c'est une étude de 2012 qui a été faite par un thésaire de chez nous, eh bien, on a retrouvé que l'âge moyen était aux alentours de 29 ans et puis que 50% des patients qui ont fait des HRP étaient entre 25 et 35 ans. Donc, c'est des femmes jeunes.

C'est des femmes en âge de procréer, encore très jeunes. Donc, c'est malheureux de voir une mortalité maternelle dans ces tranches d'âge. Et aussi, ils peuvent avoir des séquelles plus tard.

Et donc, il faut quand même garder en tête cette complication. D'accord ? Pour les Français, c'est à peu près 31 ans de moyenne, mais bon, on n'est pas loin. Quels sont les facteurs de risque de l'hématome rétroplacentaire ? Tout simplement, on va garder en tête le plus gros chapitre.

C'est quoi ? C'est la prééclampsie. Et c'est pour ça que la prééclampsie, elle est dangereuse chez les femmes enceintes parce qu'en elle-même, c'est grave, mais elle va engendrer des complications encore plus graves. Ça peut être l'éclampsie, ça peut être l'œdème cérébral, ça peut être l'OAP, ça peut être l'insuffisance rénale et ça peut être aussi l'hématome rétroplacentaire.

Donc déjà, des femmes qui ont déjà fait un hématome rétroplacentaire peuvent en refaire. Et

puis, la prééclampsie et toutes les anomalies hypertensives au cours de la grossesse. Des femmes qui ont eu des antécédents de mort fatale in utero parce que ça n'a pas été expliqué, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas vu le placenta pour dire qu'il y avait un hématome, ou bien parce qu'elles avaient une pathologie sous-jacente qui a engendré une prééclampsie non diagnostiquée.

On n'a pas fait de bilan après la première grossesse. Et donc, elles ont toujours le risque de faire, encore une fois, un hématome rétroplacentaire. Le tabagisme est un facteur assez important dans ce cadre-là et surtout il est relié aux effets, c'est-à-dire plus la dose du tabagisme est importante puisqu'on a des risques supplémentaires de faire des hématomes rétroplacentaires en dehors du contexte de la prééclampsie.

Les antécédents de retard de croissance intra-utérin ou même un retard de croissance au cours de la grossesse actuelle parce que quand on a un retard de croissance, là encore, le diagnostic le plus probable, c'est plus fréquent. Dans les retards de croissance, c'est quoi? C'est toujours la prééclampsie. C'est toujours la pathologie vasculaire, ça s'appelle, d'accord? Parce que la prééclampsie, c'est une pathologie vasculaire placentaire qui est responsable de tous ces problèmes.

La thrombophilie, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, c'est une prédisposition héréditaire ou innée à faire des maladies thromboemboliques, mais aussi à avoir des problèmes des moustaches. Ce sont des patientes qui parfois ont des pathologies systémiques associées à la thrombophilie. Parfois, elles n'ont que la thrombophilie.

Elles sont aussi susceptibles de faire une pathologie vasculaire placentaire et faire secondairement des hématomes rétro-placentaires. La multiparité, les traumatismes directs sur l'utérus et là, par exemple, une patiente qui a eu un AVP et qui a un point d'impact abdominal, sachez qu'il y a un risque de développer un hématome rétro-placentaire traumatique et c'est pour ça que ce sont des femmes qu'en général, on va surveiller pendant au moins 24 heures parce que l'hématome, c'est quoi? C'est un petit saignement qui va commencer et puis soit l'hémostase est faite et c'est terminé, soit l'hémostase n'est pas faite, l'hématome va augmenter, il va décoller de plus en plus le placenta autour et donc on va avoir un effet boule de neige et on va avoir un hématome qui va devenir de plus en plus gros et donc ça n'apparaît pas immédiatement, ça va prendre un peu de temps pour l'apparition de l'hématome et c'est pour ça que c'est des femmes qui ont eu des traumatismes, on doit les surveiller pendant 24 heures au milieu hospitalier. Aussi, des traumatismes plus minimes et beaucoup plus iatrogènes comme par exemple la version externe qui peut se faire si on a une présentation de siège et on veut le tourner en céphalique ou une transverse et on veut la tourner en céphalique ou en siège, ça aussi, ça peut, à cause de la manipulation abdominale, on peut créer un décollement et on peut créer un hématome rétro-placentaire.

Il y a aussi les accidents funiculaires, c'est la traction par le fœtus sur un cordon bref, c'est-à-dire

un cordon court. Si le fœtus est en train de tourner, il a un bretel, donc il tire sur son cordon, il peut entraîner de façon mécanique un décollement placentaire qui va donner un hématome rétro-placentaire. Donc ça, c'est l'aspect anatomique d'un placenta normal.

Remarquez ici, ça c'est la face fœtale et on la reconnaît par la présence du cordon et de la vascularisation ombilicale. Et puis le côté maternel, ça s'appelle aussi la plaque choréale. Et puis la face maternelle, c'est-à-dire la face qui est accolée sur la paroi utérine, c'est-à-dire au niveau de laquelle les artères utérines vont arriver dans les chambres intervilleuses, ça a l'air comme ça.

Et ça, c'est un aspect, je ne sais pas si vous le voyez, je le vois mieux sur mon PC, il faut que ça soit régulier, d'accord? C'est une surface qui est régulière. C'est vrai que vous avez l'impression qu'il y a des hauts et des bas, mais quand même l'épaisseur est homogène. Quand il y a un hématome rétro-placentaire, on va avoir ce qu'on appelle des cupules.

La cupule, c'est comme un bol, comme ça, il va emprunter sur le placenta. Donc vous allez trouver un aspect normal, puis une empreinte qu'on appelle cupule d'HRP à cause de cet hématome qui a poussé cette paroi vers le dedans. Et c'est pour ça qu'en général, quand on fait un accouchement, quelque soit, voie basse ou césarienne, il faut avoir le réflexe d'aller regarder le placenta.

Il faut faire ce qu'on appelle l'examen du délivre. On prend le placenta, on le met sur une table avec une bonne lumière, on met des gants et puis on examine correctement la face maternelle. Et là, on peut chercher cette cupule dont on vient de parler.

On peut chercher des petites pustules qui vont donner une idée sur une infection choréale, par exemple. On peut chercher un placenta incomplet. Par exemple, un des cœtelets dents n'est pas, il est arraché, donc ça veut dire qu'il est encore chez la maman.

Et ça, ça peut créer ce qu'on appelle de la rétention placentaire et la maman peut saigner après ça. C'est pour ça qu'il faut toujours voir le placenta. Il faut aussi vérifier les membranes, s'ils sont complètes ou bien s'ils sont arrachés, etc.

Il faut examiner le corps dent pour voir qu'il y a deux artères et une veine, parce que la présence d'une seule artère peut être liée à la présence de malformations cardiaques. Et donc, si je le vois, je l'ai dit au pédiatre, le pédiatre va examiner correctement ce fœtus, il va l'osculter correctement, il peut même faire une échographie cardiaque. Donc ça, c'est l'importance d'examiner le délivre après l'accouchement.

Alors, juste pour un petit rappel, pour comprendre d'où vient le saignement dans l'hématome rétro-placentaire, ici c'est une coupe de la villosité choréale, c'est-à-dire l'unité fonctionnelle du placenta. Peut-être que vous en avez déjà parlé. Vous avez fait la délivrance, par exemple? Oui, ça c'est l'aspect de l'unité fonctionnelle.

Donc, on voit bien ici, le corps dent, c'est le côté foetal, c'est la face foetale ou la plaque coréale. Et là, il y a le corps dent qui arrive avec la veine et les deux artères, d'accord? Et qui vont arboriser de façon à ce qu'il va y avoir chaque villosité. Ça, c'est les villosités.

C'est comme les villosités de l'intestin, d'accord? C'est fait comme toute villosité pour augmenter les surfaces des échanges. C'est la même chose ici pour le placenta. Ces villosités sont là pour augmenter les échanges entre le sang maternel qui se trouve dans ce qu'on appelle la chambre intervillieuse, c'est-à-dire que c'est une chambre qui est ouverte au niveau de laquelle circule le sang maternel et dans laquelle baignent ces villosités.

C'est comme ça que se font les échanges maternofœtales. Ils se font à travers cette membrane-là. Donc, le sang artériel qui arrive hypoxygéné vient dans la villosité, il va être oxygéné, il va revenir par la veine ombilicale puisque c'est inversé chez le fœtus.

Et cette chambre intervillieuse, elle est, on va dire, nourrie par les artères utérines spirales. Donc, s'il va y avoir un décollement, où est-ce qu'il va se faire? Il va se faire en haut ou en bas? En bas, parce qu'il va se faire du côté maternel. Parce que ça, c'est le myomètre dans lequel il y a les vaisseaux spiralés utérins.

Et là, c'est ce qu'on appelle la plaque basale, c'est-à-dire la partie, donc la face maternelle du placenta. Et c'est là où il y a ces vaisseaux utérins. Alors, le décollement, il va se faire parce qu'il y a un décollement, une ouverture de cet espace entre la plaque basale ou la face maternelle du placenta et le myomètre ou l'endomètre ou l'adiposité.

Eh bien, cette ouverture, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que le saignement va venir du sang fœtal? Ça va être purement du sang maternel, puisqu'il va venir à partir de ces vaisseaux-là qui vont commencer à déverser dans cet espace et qui vont créer l'hématome, qui va être par exemple comme ça. Et voilà la cupule dont je parle. En fait, ça, ce n'est pas la cupule.

La cupule va se faire dans ce sens. Ça, ça va se faire du côté maternel, mais du côté fœtal, c'est-à-dire ce que nous allons retrouver dans le placenta extériorisé va être ici et on va trouver une cupule comme ça. Et ça va donner ce qu'on appelle une image biconvexe derrière le placenta.

Et donc, c'est un saignement d'origine maternelle et c'est la maman qui risque de faire un choc. Pourquoi c'est important de préciser ça? Parce qu'il y a un autre saignement qui peut être des deux origines. Celui du placenta prévia.

Le saignement du placenta prévia, en général, c'est un saignement double. C'est un saignement maternel et un saignement fœtal. Et c'est pour ça que dans le placenta prévia, si on tarde à faire sortir le bébé, il va sortir l'ivide, c'est-à-dire qu'il est vidé de son sang complètement blanc parce que ses villosités vont aussi être ouvertes par l'hématome et par le décollement du placenta bas inséré.

Voilà l'aspect de cupule dont je vous ai parlé. Ici, regarde, il y a le saignement-décollement qui se fait et puis ça commence à se remplir avec le sang. Puis, si les moustasses ne se font pas pour une raison ou une autre, c'est que le vaisseau rempli est gros, il y a des problèmes des moustasses dans la prééclampsie qui font et qui aggravent les hématomes rétro-placentaires, et bien ce saignement va continuer, il va remplir de plus en plus cet espace, il va pousser de plus en plus le placenta en dedans et on va avoir la surface décollée augmentée comme une boule de neige.

D'accord? Et ça, ça va créer, puisque ici la pression est très importante et l'abdomen, plutôt l'utérus avec la grossesse, c'est une enceinte fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas où cette pression va être déchargée, on va avoir le placenta qui va être comprimé et il va y avoir la création de la cupule d'acherté. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? La même chose, rupture d'une artère utéro-placentaire, un hématome d'issue basale par décollement qui va interrompre la circulation materno-fotale, il y a un caillot ici, c'est un caillot qui va être arrondi, noirâtre, qui adhère et qui déprime le placenta en une cupule due à la compression des cotylèdes. Et puis, l'hématome est toujours surmonté d'une zone placentaire infarctique, c'est-à-dire que cette zone-là, il va y avoir un infarctissement, c'est-à-dire qu'il va y avoir une congestion veineuse de cette zone-là, puisqu'il va y avoir l'interruption du flux artériel qui venait ici, de la paroi maternelle.

D'accord? Donc, c'est ça la physiopathologie de l'hématome rétro-placentaire. Alors, qu'est-ce que ça peut donner encore, l'hématome rétro-placentaire? Déjà, l'hématome en lui-même, c'est grave, d'accord? Puisque plus la surface est tendue, plus c'est un volume de saignement important pour la maman, mais aussi c'est un risque d'hypoxie et de mort fotale du fœtus. Mais d'un autre côté, il y a encore d'autres complications qui peuvent survenir et qui vont être liées au délai ou au temps entre l'apparition de l'hématome, le diagnostic et la prise en charge.

D'accord? Alors, la prise en charge, tout court, ça va être quoi, si on veut? Pardon? Ça va être l'extraction, d'accord? C'est obligatoire, parce que quand le placenta se décolle, on ne peut plus jamais le remettre à sa place. D'accord? Et donc, ça va être l'extraction dans tous les cas. On va voir pour les modalités qui vont différer en fonction des situations, mais c'est ça le traitement.

C'est comme pour la prééclampsie. Le traitement étiologique, le traitement curatif, c'est l'extraction et la délivrance. Parce que c'est le placenta qui est la cause du problème.

C'est le placenta qui a des ischémies ou qui contient des ischémies et ces ischémies vont libérer des thromboxanes vasoactives qui vont donner tout le problème de la microvascularisation. D'accord? Si vous n'enlevez pas le placenta ou s'il vous reste un morceau de placenta chez une patiente prééclampsique, sachez qu'elle peut garder ses symptômes même après l'accouchement. Et donc, quand on a, par exemple, une patiente qui fait une éclampsie du postpartum, c'est-à-dire qu'elle a accouché, d'accord? Mais une heure, deux heures après, elle fait son éclampsie.

Le premier réflexe, c'est d'aller voir l'utérus et voir s'il est vide, s'il n'y a pas de cotylédons qui restent à l'intérieur. Parce que ce cotylédon ischémique continue à libérer les substances vasoactives qui vont donner l'œdème cérébral et qui vont donner, par exemple, la confusion. Il va libérer aussi des substances vasoactives qui vont créer, donc, une vaso, plutôt des microthromboses dans le foie, dans les reins.

Et là, on peut avoir un hématome sous capture du foie, on peut avoir une assistance rénale, etc. Donc, c'est la délivrance qui permet le traitement de la prééclampsie. Après, il y a cette forme, regardez ici.

Ça, c'est un utérus, d'accord? C'est un utérus, ça, c'est les cornes. Et regardez comme il est bleu, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un utérus en hypoplexie, ou un utérus de couvreur, d'accord? Qu'est-ce qui se passe quand on a cet hématome et quand cet hématome est étendu? On a vu qu'il y a un enfarcissement du placenta devant l'hématome. Alors, cet enfarcissement peut s'étendre aussi parce qu'il y a une hyperpression.

Vous imaginez que vous avez, comment on peut l'expliquer sur le plan physique? Vous avez comme un ballon mais qui en épanche. Et vous êtes en train de faire une pression importante sur ce ballon de l'intérieur. Qu'est-ce qui va arriver à sa paroi? Elle va être comprimée aussi.

Et donc, pour la paroi, pour le placenta, on a vu que ça va interrompre la scolarisation artérielle. Ça va aussi donner une, comment on l'appelle? Je viens de le dire. Une congestion, d'accord? Puisque le retour veineux lui-même ne va pas se faire.

Et le sang qui va y rester va rester congestif. C'est ce qui donne cet aspect bleu, d'accord? Et donc, cette congestion va, plus il y a un saignement dans l'hématome, plus la pression intra-utérine va augmenter. Elle va engendrer une souffrance de la paroi myométriale elle-même qui va faire que sur ses veines, il va y avoir de la suffusion hémorragique.

Comme si les veines vont éclater, ils vont laisser passer un peu de sang dans l'espace intercellulaire. Et ça, ça donne un aspect bleu comme ça. C'est une suffusion hémorragique qui s'étend à toute la paroi utérine.

C'est comme si, vous savez quand vous avez un traumatisme, on va dire, de la cuisse ou du quadriceps. Qu'est-ce qui se passe? Il va fuser entre les faisceaux musculaires et ça va donner une suffusion de tout ce muscle-là. Et ça, c'est ce qui se passe sur l'utérus dans des stades avancés de l'hématome rétro-placentaire.

Et donc ici, on appelle ça l'utérus de couvreur. Cette suffusion peut s'étendre aussi au petit bassin, c'est-à-dire on peut même la retrouver sur la paroi de la vessie et la paroi du pelvis. Et parfois, ça peut aussi s'étendre un peu plus loin sur le foie, sur les reins, etc.

Donc là, ce sont des lésions équimotiques avec suffusion hémorragique et œdème. L'hématome

va diffuser, va disséquer les fibres musculaires de l'utérus. En fait, c'est un aspect qui est spectaculaire, c'est-à-dire surtout quand on fait la césarienne, on voit ça quand on fait l'accouchement en voie basse, ça peut exister et on ne le voit pas.

Mais ça, en césarienne, on peut le voir. Quand on le voit, on est choqué, on a l'impression que c'est très grave. C'est vrai que c'est une situation grave, mais l'aspect est plutôt, on va dire, plus de peur que de mal.

C'est-à-dire que c'est un aspect qu'on respecte. On sort le bébé, on suture l'utérus, et puis on va traiter médicalement et en général, ça va bien. C'est-à-dire que ce n'est pas un utérus nécrosé qu'on doit retirer.

Non, il va reprendre, il va guérir et reprendre sa vascularisation normale. Sur le plan microscopique, qu'est-ce qui se passe si on envoie un placenta avec un hématome rétro-placentaire ou si on envoie carrément une hystérectomie dans des situations graves? Ce qui arrive, c'est que sur ce schéma, vous voyez qu'il y a plusieurs situations. Par exemple, ici, est-ce que ça, c'est un hématome rétro-placentaire? Ça, c'est la paroi utérine, ça, c'est le col utérin, ici, c'est la cavité avec le liquide amniotique et ça, c'est le placenta.

Est-ce que ça, c'est un hématome rétro-placentaire? Non, ça s'appelle un hématome marginal, il est à la périphérie. Ce genre d'hématome n'augmente pas la pression énormément derrière le placenta et donc ne va pas s'étendre de façon grave et ne va pas donner d'autres complications. La même chose si on voit, par exemple, que ce soit ici ou là, on est toujours dans le marginal, mais ici, regardez la différence, c'est qu'il est derrière le placenta, il n'est pas marginal et il va créer une suffusion hémorragique et une ischémie, pas d'ischémie, une contusion, si vous voulez, du placenta et il va donner cette fameuse cupule.

Et voilà l'hématome rétro-placentaire. Même macroscopiquement et microscopiquement, c'est particulier. Ici, c'est juste une description microscopique, on n'est pas obligé de la retenir à 100%.

Il y a une collection d'hématocytes qui sont insérés dans le réseau fibrin de cet espace-là et les lésions vont siéger au niveau de cette plaque basale du placenta et quand l'anatome pathologiste lui donne la pièce de placenta qu'il peut étudier, il va trouver des zones de vasodilatation, de thrombose et même des zones de rupture du placenta à ce niveau-là. Il y a plusieurs hématomes qui peuvent survenir dans un placenta. Le plus important dont on parle, c'est-à-dire qu'il est franchement rétro-placentaire.

Ça saigne à partir de la plaque basale et ça crée la cupule et il y a en regard une zone de contusion, une zone de suffusion hémorragique. Mais on peut à l'échographie, accidentellement, quand on fait la surveillance de la grossesse, il peut se trouver des images hypoéchogènes intra-placentaires qui peuvent être d'autres origines ou d'autres hématomes mais qui sont moins graves. Subamniotiques, c'est-à-dire juste en dessous des membranes, ils peuvent être intra-parenchymateux.

Ici, c'est un gros hématome subchoréonique et à chaque fois qu'on a des espaces ou des surfaces importantes d'hématomes, là, ça va donner comme un aspect tumoral à l'intérieur du placenta. Bien évidemment, ça va créer un peu de désordre parce qu'il y a une surface qui va sauter par rapport à la perfusion. Mais ce qui est intéressant dans le placenta, c'est que quand une zone est malade, le reste, ça fonctionne et ça fonctionne très bien et le fœtus peut ne pas sentir.

Dans ces situations-là, on va juste surveiller ces patientes-là, comme on peut avoir d'autres types d'hématomes subchoréoniques, mais c'est celui-là qui génère beaucoup de problèmes. Ce n'est pas fini parce que quand on a l'hématome rétro-placentaire, comme on a dit tout à l'heure, ça ne saigne pas à l'extérieur. La patiente va sentir une douleur atroce et c'est cette douleur qui déclenche le processus de diagnostic.

Mais parfois, ça va prendre un peu de temps, par exemple, pour qu'elle arrive au niveau de l'unité de soins qui va faire le diagnostic. Et là, plus le temps avance, plus on risque d'avoir toutes les complications de l'hématome rétro-placentaire lui-même. Premièrement, la souffrance fœtale subaiguë, c'est-à-dire qui va se faire progressivement, ce n'est pas aiguë.

Aiguë, c'est quelques minutes, c'est terminé. Subaiguë, ça va prendre quand même quelques heures. Alors que la chronique, c'est plusieurs semaines.

Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une réduction de la surface des échanges et donc une époxie et ça va aggraver l'existence d'une époxie chronique, c'est-à-dire d'une souffrance chronique déjà existante à cause de la prééclampsie et à cause du retard de croissance in utero. Donc, soit que le bébé n'avait pas de retard de croissance, ce n'est rien du tout, et là l'hématome va donner cette souffrance, soit il est déjà souffrant ce bébé avec une prééclampsie sévère. Dès que l'hématome rétro-placentaire commence, on va voir que le rythme cardiaque va vraiment être anormal.

Il y a ce qu'on appelle l'hypertonie, ça c'est l'hyperpression intra-utérine, puisqu'on a expliqué que plus le volume est important, plus il va y avoir de la pression à l'intérieur de cet utérus-là et ça on peut le sentir cliniquement. D'ailleurs, la patiente peut vous dire que son utérus est un utérus de bois, c'est comme du bois, d'accord, et puis ça ne se relâche pas, parce que là il faut faire la différence entre ce qui est hypertonie et la contraction utérine, parce que la contraction utérine elle-même c'est une hypertonie mais qui est transitoire. Il va y avoir un pic de pression intra-abdominale à cause de la contraction musculaire, puis ça va relâcher, puis ça va réapparaître, puis ça va relâcher à des rythmes différents en fonction de ce qu'on est au début du travail, à la fin du travail, etc.

Mais quand on est en situation d'HRP, il y a ce qu'on appelle l'hypertonie qui est différente, c'est que le tonus de base, si on vous a parlé de la topographie, il y a le tonus de base, puis il y a les

contractions ou les relâches. Mais là le tonus de base va augmenter très haut, et là on appelle ça l'hypertonie, et ça ne va pas se relâcher du tout. Donc c'est une femme qui va venir en criant, ça c'est donc le tableau bruyant, mais il y a des tableaux plus frustrés qu'on ne diagnostique pas facilement.

Elle va venir avec une douleur intense qui est due au décollement, et avec un utérus en bois, il suffit de mettre la main dessus pour voir qu'il est tendu et que ça ne se relâche pas, même si vous attendez quelques minutes par exemple. C'est l'hypertonie utérine. Alors ici, il faut avoir un réflexe, qui est la rame.

C'est quoi la rame? Artificielle des membranes, oui. Alors là, cette rupture artificielle des membranes peut être d'un grand secours. Le problème, il y a l'hématome, il est là, il crée une hyperpression, cette hyperpression va encore tirer sur le placenta, il y aura l'augmentation, l'aggravation de l'hématome lui-même.

Ce qu'il faut faire si on a une patiente qui a un col ouvert et on a l'accès aux membranes, le premier réflexe au moment du diagnostic et notamment à l'admission, c'est de rompre la poche des os. Donc si vous rompez la poche des os, l'encreinte va devenir une encreinte ouverte au milieu extérieur et donc il va y avoir une réduction de la pression intra-utérine et le muscle utérin va se relâcher. Il n'y aura pas d'aggravation de l'hématome, ça ne fera pas disparaître l'hématome, parce que l'hématome rétro-placentaire, c'est un aller sans retour.

On ne va pas revenir en arrière, il est là, ça y est, on va le gérer. Mais la rupture prématurée des membranes, non pas prématurée, mais artificielle des membranes, va nous donner un laps de temps pour diminuer la pression intra-cavitaire ou intra-utérine et ça va nous donner une protection du fœtus et ça va nous donner un délai, le temps de la transporter par exemple ou le temps de la faire admettre au bloc opératoire. C'est aussi un réflexe quand vous avez un placenta bas inséré, mais qui n'est pas totalement recouvrant.

Vous avez dit ça? Vous avez fait placenta prévia? Oui. C'est aussi un réflexe, parce que l'hématome, c'est toujours une question de décollement. Quand un placenta prévia saigne, c'est aussi parce qu'il y a des contractions.

Les contractions augmentent la pression intra-utérine et tirent sur les membranes et ça décolle et puis ça saigne. Donc si on a un placenta prévia non totalement recouvrant, c'est-à-dire qu'on a accès aux membranes par le col utérin, on peut là aussi remplir la poche des os et ça va améliorer le saignement. D'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer en plus dans cette situation-là? C'est qu'il va y avoir la libération d'une quantité importante de prostaglandines qui va intervenir dans cette situation.

Et ces prostaglandines, on sait que les prostaglandines donnent des contractions utérines, qui permettent le déclenchement du travail. Et donc, ils vont être aussi responsables de cette tonicité de l'utérus. Puis avec le saignement, il va y avoir un état de collapsus maternel, donc une baisse

de la pression artérielle maternelle, qui va bien évidemment aggraver la asphyxie fœtale, puisque le débit utérin va chuter aussi, comme la pression artérielle.

Et donc, ça va aggraver l'asphyxie fœtale. Et c'est pour ça que quand on gère un hématome rétro-placentaire, on doit continuer à surveiller de près la tension artérielle de la patiente et aussi le rythme cardio-fœtal du fœtus. Et parfois, ça c'est dans les situations les plus graves, parfois cette situation peut être limitée dans une petite surface, sans retentissement fœtal, et le diagnostic ne se fera que quand on va regarder le placenta et trouver un cupule.

En fait, c'est une chose qu'il faut faire encore plus systématiquement quand on gère une prééclampsie sévère, quand on gère une souffrance fœtale aiguë inexpliquée, parce que ça peut être un HRP et on ne le savait pas, et aussi quand on accouche un mort fœtal in utero, il faut aller regarder le placenta pour chercher s'il y a un HRP ou pas. Une complication encore plus grave qui est les troubles de l'hémostase que peut engendrer l'HRP. Donc, on vient de voir qu'il peut engendrer la souffrance fœtale sub-aiguë et qu'il peut se compliquer des morts fœtales.

Il peut engendrer l'altération de l'état hémodynamique maternel et donc c'est l'état de choc maternel. Mais au cours de tout ce phénomène-là, il y a aussi un risque de développement d'anomalies de l'hémostase. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on a le décollement placentaire, il va y avoir, comme dans la prééclampsie, la mise en circulation dans la circulation maternelle à travers cette chambre intervilleuse de substances ou de matériel thromboplastinique d'origine placentaire et qui va créer un emballement du système de coagulation maternelle.

C'est-à-dire qu'il va simuler la coagulation maternelle et on sait que si cette coagulation se fait sans phénomène barré, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une consommation énorme de fibrinogènes, une consommation des plaquettes, une consommation des facteurs de coagulation et sur le plan général, ça va créer un phénomène de la coagulation intravasculaire dissimulée. Donc là encore, le placenta va être responsable dans cette situation de congestion de la libération de substances qui va générer une activation du système de coagulation maternelle. D'accord? Et ça, ici, cette CIVD est l'une des situations les plus graves à gérer dans l'HRP et qu'on craint tous et qu'on essaye d'agir le plus vite pour ne pas y arriver.

Parce que la CIVD, c'est toujours une question de temps. Je pense qu'on vous en a parlé dans l'hémorragie de la délivrance, par exemple. Oui? Telle soit l'hémorragie de la délivrance.

L'hémorragie de la délivrance, c'est chrono. C'est une question de temps. Il faut faire vite.

Il ne faut pas laisser perdre le temps parce que plus la patiente saigne, plus elle consomme ses plaquettes, son hémoglobine, ses facteurs de coagulation, et plus elle va rentrer, elle aussi, dans ce système de coagulation intravasculaire disséminé. Parce qu'en même temps, il y a l'hémorragie, mais il y a aussi les microthrombus. D'accord? Et donc, là, on va retrouver, bien évidemment, l'action fibrinolytique physiologique et on va trouver une augmentation des produits

de dégradation du fibrinogène et qui ont aussi un rôle anticoagulant.

C'est ce qui va donner le saignement, bien évidemment. Donc, dans cette situation-là, il y a toujours une thrombopénie, un TP, un temps de prothrombine qui va être effondré, et la chute du fibrinogène et l'augmentation des PDF. D'accord? Et ça, ça va aggraver l'hémorragie dans l'hématome lui-même, déjà.

D'accord? Ça va aggraver l'apoplexie de couvreur, c'est-à-dire puisque ça ne coagule pas, donc le sang va fuser entre les fibrins musculaires. Ça va en plus engendrer des saignements viscéraux, c'est-à-dire que cette femme va avoir une gingivorragie, elle peut avoir des pâches, elle peut avoir une hémorragie cérébrale, elle peut avoir un hématome sous-capsulaire du foie, etc. D'accord? Et enfin, l'hémorragie de la délivrance.

Alors, parce que dans des situations comme ça, on est obligé de l'accoucher, là, madame. C'est un hématome rétro-placentaire, on n'a pas le choix, comme dans la prééclampsie sévère. Il faut l'accoucher.

Mais le problème, c'est qu'elle a en plus des problèmes d'hémostase, c'est-à-dire une hypocoagulabilité. Donc, vous imaginez que les risques d'hémorragie et de la délivrance sont énormes. Et parfois, ça va être difficile de le... Bon, actuellement, quand même, on arrive à agir rapidement.

On a des produits médicaux qui vont aider. On fait de la transfusion du sang, des globules... Enfin, des culots globulaires, des plaquettes, des PFC, PFC avec les facteurs de coagulation. Et si on est dans les pays qui se permettent d'avoir les facteurs de coagulation ou perfusion, c'est le moment de les injecter.

Et on peut redresser la situation si on arrive à faire ça rapidement. Mais sinon, parfois, ça peut aller jusqu'à une hystérectomie d'hémostase, par exemple. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des femmes jeunes, parfois, au début de leur vie de reproductif, et c'est malheureux.

Et là, même avant qu'on termine le cours, je vous donne les recommandations. Comment on peut éviter des situations comme ça, à votre avis? Situation dramatique. Bien évidemment, on fait l'hystérectomie d'hémostase, mais malheureusement, même l'hystérectomie d'hémostase ne va plus être suffisante, parce qu'avec la CVD, tous les tissus saignent, même le péritoine, même la plaie opératoire saigne, même si on a enlevé l'utérus, qui normalement saigne beaucoup, mais elle peut avoir d'autres saignements.

Parfois, on a besoin de mettre des champs opératoires à demeure dans l'abdomen, de fermer dessus, de faire de la pression pour que le saignement s'arrête, le temps de donner le traitement médical. Si on considère que des situations comme ça, elles sont plus fréquentes dans le contexte de la prééclampsie, donc quelle est la recommandation conceptionnelle? Pourquoi? Les risques, on peut les voir aussi dans la consultation prénatale. La première, mais surtout, qu'est-

ce qu'il faut faire au cours de cette consultation prénatale? Surveillance 2. Ça va rentrer dans quel cadre? C'est pas de la prévention quand tu mesures de l'attention, c'est le dépistage, d'accord? C'est le dépistage de la prééclampsie, c'est-à-dire quand une patiente enceinte vient dans un cabinet pour faire sa consultation prénatale, le premier réflexe est de prendre de l'attention artérielle et faire la microalbuminurie.

Parce que c'est des femmes, si on les diagnostique tôt, on peut les traiter et ça peut améliorer le pronostic. Sinon, dans des formes plus graves, on peut les accoucher plus tôt pour ne pas attendre la complication. Et la prévention, par contre, va passer par, par exemple, l'administration de l'aspirine chez des patients chez qui on a trouvé des facteurs de risque au début de la grossesse ou la consultation préconceptionnelle.

Il y a aussi actuellement la possibilité de faire de la prévention par le calcium, par la dose élevée de calcium quotidienne chez les femmes enceintes, d'accord? Et donc, toutes les complications, et ça, je pense à la surveillance de la grossesse, tous les gros problèmes obstétricaux qui peuvent donner la mortalité maternelle sont évitables par une bonne consultation prénatale, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter encore dans cette physiopathologie si longue? C'est les autres, bon, c'est à part la prééclampsie, les autres circonstances de survenue de cet hématorne. Parfois, ce n'est pas expliqué du tout. Donc, il n'y a pas de prééclampsie, mais il y en a quand même un HRP et ça va donner les schémies utéroplacentaires.

La situation des traumatismes, et donc, on en a déjà parlé, soit traumatisme évident, soit lorsqu'on fait des manœuvres utérines, quand on fait la myosynthèse, quand on ponctionne pour évacuer un hydromyose et on fait une évacuation très rapide chez des femmes qui ont des avortements multiples, des utérus multiscatriciels. Et parfois, il n'y a pas de cause évidente, justement. Il y a plusieurs facteurs qui augmentent le risque.

Léanmoins, la malnutrition, le tabagisme, la multiparité et puis les habitudes toxiques, c'est-à-dire la cause à effet direct n'est jamais établie. Donc, rapidement, puisqu'on a compris tout ça, on va juste répéter et fixer les choses. Si on veut faire le diagnostic de l'HRP, la forme clinique la plus fréquente, c'est la forme grave, d'accord? Et c'est la forme qu'on ne devrait pas rater, d'accord? Parce que parfois, c'est très brouillant et l'HRP parle de lui-même.

Et on peut faire le diagnostic cliniquement. On n'a même pas besoin ni de faire une échographie ni quoi que ce soit. On peut faire le diagnostic cliniquement de l'HRP.

Alors, en général, c'est une patiente qui a un tableau de prééclampsie, soit qu'elle est connue, soit à l'arrivée, vous trouvez une hypertension artérielle, vous trouvez une albuminurie positive, une patiente bouffée avec un visage oedématisé des jambes inférieures, donc avec des oedèmes membres inférieurs. Soit elle va arriver carrément avec un état de choc épo-volumique avec une hypotension, tachycardie, froideur d'extrémité, etc. Alors, si cette patiente arrive à parler, elle va vous décrire les douleurs abdominales brutales en coups de couteau qu'elle peut vous donner

précisément avec l'heure.

Et c'est important de connaître l'heure de début de ces douleurs parce que ça, ça va vous donner une idée sur le délai d'évolution justement de l'HRP. Elle va avoir une métrorragie minime par rapport à l'état de choc que vous trouvez. C'est vrai que vous pouvez la trouver en hypertension artérielle, mais par exemple, si c'est une patiente qui est prééclampsique et qui était à 18 de tension et qui fait son HRP, si elle est à 12, elle est déjà en état de choc.

Comprenez? Par exemple, vous avez admis une patiente prééclampsique, elle était à 18, 17, 11, vous traitez. Mais à un certain moment, vous remarquez que rapidement, elle descend à 12, elle descend à 11, elle commence à devenir tachycardie, mal à l'aise. D'accord? Elle commence à avoir le stress du choc épivolémiqque.

Eh bien, vous devez considérer ça comme un état de choc quand même. D'accord? Et quand vous regardez le saignement, c'est un saignement minime ou en rapide parce qu'on a compris que ça se passe dans une enceinte fermée, que le saignement ne va jamais s'extérioriser, puis c'est un caillot. D'accord? Surtout dans la phase aiguë, quand le saignement se fait, le caillot se constitue.

Mais si on tarde un petit peu, ce caillot va se solubiliser et là, ça va donner une image différente à l'échographie. Et puis, elle peut présenter aussi des nausées vomissements et elle a des tendances acropales. Donc, si il y a une patiente qui peut vous dire que j'ai perdu la connaissance à la maison ou bien en voiture, quand les pompiers la ramènent et ils vous disent qu'elle a perdu la connaissance à un moment donné.

Alors, quand vous allez examiner, d'abord, vous allez chercher les signes du choc, donc la tension artérielle. Donc, comme j'ai dit, ça peut être une tension artérielle élevée. Vous savez que vous êtes dans un contexte préclampsie ou bien complètement effondrée.

C'est un choc hémorragique. Elle peut avoir des signes de CIVD avec des saignements non gynécologiques comme des échymoses, comme des hématomes au point de perfusion, par exemple, ou de prélèvement. Elle peut avoir des pétéchés, peut avoir des gingivorragies.

Et puis surtout, cette contracture utérine qui est permanente et qui est douloureuse et avec une hyperesthésie. C'est-à-dire, dès que vous posez la main, elle a mal. Elle ne vous laisse pas toucher son ventre parce que ça fait très mal.

Et en plus, quand vous le touchez, c'est quand même très, très, très dur. Quand vous aurez touché un HRP, les gens qui passent au service, vous n'allez pas oublier cette situation-là. Donc, c'est une contraction qui est permanente, qui ne se relâche pas.

D'accord? Et puis, des fois, on peut trouver des BCF négatifs. D'accord? Métrorragie, BCF négatif, HRP jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Il faut faire très attention à cette relation-là.

Sachez que la paraclinique ne devrait jamais retarder la prise en charge thérapeutique d'un HRP puisque, comme on a compris, c'est une question de temps. C'est une cascade. Ça saigne un petit peu, ça commence à la tension augmenter, le saignement s'aggrave, l'hématome grandit, la surface augmente, le bébé perd sa perfusion.

Quand le placenta se décolle, il est congestionné, il commence à libérer des substances dans la circulation systémique de la patiente. Eh bien, ça va donner toute la cascade de coagulation qui va être déclenchée et donc, plus on tâte, plus ça va être encore plus grave. Donc, si j'ai tous les éléments cliniques, c'est un HRP.

Et si c'est une patiente qui était suivie, qu'on connaît qu'elle est enceinte, à quels termes, etc., on peut prendre la décision immédiatement de la coucher ou de la Césariser pour un sauvetage materno-fatal, si le bébé est vivant, ou c'est un sauvetage maternel, uniquement si déjà le bébé est ABCF négatif. Mais des fois, quand le tableau est moins grave, qu'il n'y a pas encore l'état de choc, etc., on peut se permettre de faire une échographie obstétricale, surtout chez une patiente qui n'est pas du tout suivie. On n'a aucune idée du terme, on n'a aucune idée de ce bébé, est-ce qu'il est bien formé, mal formé.

On ne sait pas si c'est des jumeaux ou si c'est des triplés. Peu importe, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée, on n'a même pas d'idée sur l'emplacement du placenta pour dire que c'est un saignement d'un placenta normalement inséré ou bien c'est un hématome tout court, tout en sachant que les associations sont possibles. C'est-à-dire que je peux avoir un placenta prévia, mais qui fait un HRP.

Et là, je dois le savoir, surtout si je suis le chirurgien et je vais faire la césarienne, ou si je décide de la coucher par voie basse, si c'est un placenta bas inséré, je ne peux pas le faire. Sinon, si je veux opérer, je dois connaître l'emplacement du placenta pour ne pas rentrer dans le placenta en peropératoire. Et donc, des fois, c'est important ou intéressant de faire une échographie obstétrique.

D'un côté, ça va confirmer la mort fatale, parce que des fois, avec l'hypertonie utérine, le sang cardiaque ne va pas arriver à la superficie. Donc, on va conclure à des BCF non perçus. Et donc, on devrait quand même jeter un coup d'œil pour voir si vraiment ce fœtus a un cœur arrêté ou bien il continue à battre.

Parfois, on va visualiser l'HRP. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas facile de le voir, surtout au début, parce qu'au début, c'est un caillot, comme j'ai dit.

Quand c'est un caillot, à l'échographie, ça va être le même aspect que le placenta. C'est-à-dire une image écogène, finement hétérogène. Mais à des stades tardifs, quand le matin va se liquifier, ça va devenir du liquide.

Là, on va voir cette image rétro-placentaire, hypo-écogène, noire, mais qui est plus convexe.

C'est ça, la caractéristique de l'image. Bien évidemment, ça devrait être fait le plus rapidement possible.

C'est-à-dire quand on prend la voie veineuse ou les voies de voie veineuse de sécurité dans une situation de choc, ou même quand on suspecte un HRP, on va faire le prélèvement sanguin immédiatement. Bien évidemment, on va voir sa NFS, son TP. On va vérifier son regroupage parce qu'on va peut-être demander du soin après.

Et puis le bilan de l'après-éclampsie que vous avez déjà étudié. Voilà une image d'un hématome. Vous voyez, ça, c'est l'aspect du placenta.

Et là, quand c'est un peu noir, c'est hypo-écogène, c'est convexe. Ça, c'est un hématome rétro-placentaire. La paroi utérine, elle est là.

Ça, c'est la superficie, c'est-à-dire la peau de la madame. Ça, c'est le liquide amniotique au niveau de l'abdomen. D'accord ? Donc, on peut des fois visualiser cette cupule hypo-écogène à l'échographie.

Voilà une autre image. Et là, vous voyez que c'est quand même hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a encore des caillots. Donc, le fœtus, il est là.

Le placenta, l'aspect normal, c'est ça. C'est un aspect qui est quand même écogène, finement écogène. Et vous voyez que cet hématome, il est convexe et il est derrière le placenta avec la paroi utérine en arrière.

Et là, c'est un tableau qui peut vous récapituler. C'est un tableau qui est pris de la thèse qui a été faite dans notre service par rapport aux différents HRP. Là, c'est les différentes formes cliniques qui peuvent exister.

C'est-à-dire ce qu'on vient de voir avant, c'est une forme grave. En état de choc, il y a un saignement, c'est un utérus en hypertonie, les BCF sont négatifs. Tout ça, c'est la totale.

D'accord ? C'est une forme grave. Mais parfois, on peut avoir des formes différentes. Donc, la forme complète, il y a dit, l'hémorragie, l'hypertonie, BCF négatif.

Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, c'est un HRP clinique. OK ? Les formes post-symptomatiques où il y a des symptômes moins nombreux, les deux signes, on peut avoir métrorragie et hypertonie, comme on peut avoir métrorragie et BCF négatif.

Le placenta qui est un BCF négatif, attention, c'est un HRP, même si l'hypertonie n'est pas là. D'accord ? On peut aussi avoir un seul signe, uniquement la métrorragie, uniquement l'hypertonie, ou une mort fatale, une utéro inexplicée. Il n'y a rien d'autre.

Mais quand on va voir le placenta après l'accouchement, on va trouver la cupule. Puis, les

formes asymptomatiques où il n'y a aucun signe, d'accord, et qu'on est surpris quand on fait la délivrance du caillot qui arrive avec le placenta. Et quand on va examiner, on trouve l'HRP.

En général, ça doit être des cupules de petit diamètre, pas des grandes cupules. Et il y a les formes qui sont associées à une pathologie obstétrique à la gynécologie. Notamment, on peut avoir avec l'eclampsie, ça fait partie des formes graves de l'après-eclampsie.

C'est une des complications. On peut avoir les deux associées au placenta prévia. Donc, vous voyez qu'ils peuvent être associés au placenta prévia.

Et là, il faut faire attention. Est-ce que le saignement est à cause de l'HRP ou à cause du placenta prévia ? A votre avis, il y a une différence ? On peut le connaître cliniquement ? L'abondance est la couleur. Alors, quelle est la différence de la couleur ? Alors, c'est mini, mais noirâtre dans l'hématome rétro-placentaire.

Noirâtre, c'est toujours un sang ancien, un sang digéré. C'est-à-dire qu'il était là à un bon moment et puis il a glissé vers le col. Mais le placenta prévia, c'est un saignement frais, c'est un saignement rouge, c'est un cailloté à l'extérieur.

Et en général, il peut être abondant. Et puis, les maladies abortives, c'est-à-dire les femmes qui font des avortements répétitions, pourquoi ? Parce qu'on a dit que l'HRP peut être associé à un contexte de thrombophilie. Ce sont des femmes qui peuvent avoir des pertes fœtales assez fréquentes.

Et donc, voilà les différentes formes dans la clinique. Il y a la forme grave aussi, mais avec un fœtus vivant, celle qu'on a vu tout à l'heure, un fœtus mort. Les formes frustes, donc c'est les possysymptomatiques et les formes asymptomatiques.

Les formes latentes, où on a la mort fœtale en retard de croissance, mais on ne sait pas qu'il y a l'hématome rétro-placentaire. Sur le plan anatomique, il y a les formes étendues, c'est-à-dire, alors, ces formes étendues avec apoplexie, ce n'est pas toujours synonyme de la gravité, je vous l'ai bien dit, d'accord ? Des fois, c'est un HRP où le bébé est encore vivant et qu'il n'y a pas de trouble des moustades, mais quand même, on trouve qu'il y a l'apoplexie utérine et les formes compliquées, c'est-à-dire compliquées avec le choc hémorragique et avec la CIV. Ici, c'est une classification qui est intéressante à connaître parce que c'est avec ça qu'on va décider de notre prise en charge.

Alors, c'est une classification de chair qui gradifie le CHRP en trois grades. Le grade 1, quand vous avez uniquement la métrorragie, donc il n'y a pas autre chose, mais quand on arrive à faire le diagnostic, soit à l'échographie, par exemple. Le grade 2, où nous avons la symptomatologie clinique plus complète avec le fœtus qui est encore vivant et puis le grade 3, c'est quand vous avez une forme complète mais avec un fœtus mort.

Mais là encore, il y a la forme 3A, où il n'y a pas de trouble de coagulation et le 3B, il y a des troubles de la coagulation. Donc, cette classification va nous servir pour la conduite à tenir obstétrique ultérieure. Bon, ça, ça reprend juste ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que plus on attend, plus on a des complications plus importantes, notamment la CIVD, l'inertie utérine, ça veut dire l'hémorragie de la délivrance après, l'état de choc, la souffrance rénale et puis malheureusement, on peut avoir la mortalité maternelle et aussi la mortalité fatale.

Là, par contre, c'est aussi important à retenir parce que c'est ce qui peut prêter à confusion, c'est-à-dire les diagnostics différentiels. Alors, il y a trois situations qu'on doit vérifier. On va faire un diagnostic différentiel devant la métrorragie du troisième trimestre puisque l'HRP, Gounab et Anna, je ne sais pas où ils sont, mais ils vont se souvenir de plus ou plus fréquemment au troisième trimestre, comme toutes les complications de la prééclampsie, c'est-à-dire la période la plus dangereuse, c'est le troisième trimestre, d'accord? Et donc, quand il y a un saignement au cours du troisième trimestre, c'est un chapitre qui s'ouvre, c'est la métrorragie du troisième trimestre, on doit le connaître.

Et là, les diagnostics différentiels, c'est toujours placenta previa, la menace d'accouchement prématuré et là, faites attention, on a vu, chaque obstétricien de nous a vécu dans sa carrière des situations de menace d'accouchement prématuré qui étaient des HRP ou l'inverse, d'accord? C'est-à-dire que la patiente arrive avec une métrorragie au troisième trimestre, elle a une situation de prématurité, c'est-à-dire moins de 37 semaines, elle n'est pas connue porteuse d'un antécédent particulier ni de prééclampsie, rien du tout, ok, elle contracte, on trouve une modification du col et ça, c'est la définition de la menace d'accouchement prématuré, on va traiter, on va tout coulisser, d'accord? Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut garder en tête que l'HRP peut se manifester par une situation pseudo menace d'accouchement prématuré, c'est-à-dire métrorragie et une douleur utérine ou une contracture utérine, d'accord? Dans les deux sens, c'est valable. Quand j'ai une menace d'accouchement prématuré, je ne dois pas oublier le diagnostic différencié de l'HRP. Quand j'ai l'HRP, plutôt que quand je suspecte l'HRP, ça peut être tout simplement une menace d'accouchement prématuré et là, on va faire l'échographie, on va vérifier totalement toute l'insertion placentaire pour éliminer le diagnostic.

Ne pas le faire une seule fois, mais il faut le refaire après six heures, par exemple, si on continue à avoir cette hantise, surtout si on a une prééclampsie, par exemple, modérée, pour vérifier l'absence de l'HRP. Puis l'hématome décidual marginal, c'est celui qui est périphérique et qui n'est pas très dangereux, mais qu'on va traiter si on est dans la prématurité comme étant une menace d'accouchement prématuré aussi, parce que pourquoi les hématomes marginaux surviennent? Parce qu'il y a des contractions qui font des tractions sur la membrane et qui tirent sur le placenta qui va le décoller. Ce n'est pas dangereux, ça ne va pas déclencher toute la cascade dont on vient de parler, mais ça veut dire qu'il y a une activité contractuelle utérine et qu'on doit, si on est en période, enfin si on est à terme et que la patiente va rentrer au travail, on accouche la patiente.

Si on est en préterme, on va devoir tocoliser. Et aussi tous les saignements qui surviennent à cause d'une lésion cervicale ou vaginale. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Le réflexe devant une métrologie de troisième trimestre, un choix de galère au examen en spéculum, d'accord? Alors, il faut garder en tête que chez une femme enceinte, on peut mettre un spéculum.

Il faut le mettre à chaque fois qu'on a des saignements, parce qu'on peut avoir un polype, comme on peut avoir un cancer du col qui saigne, comme on peut avoir, je ne sais pas, un fibromyomètre accouché, etc. Donc, il faut toujours faire un ou mettre un spéculum. Et puis, la deuxième catégorie, diagnostic différentiel par rapport à l'HRP, c'est la douleur abdominale aiguë, puisqu'on a dit que l'HRP se déclare par une douleur abdominale aiguë au coup de poignard.

Donc, ça peut être l'HRP, oui, mais des fois quand le tableau est incomplet, on peut aussi avoir tous les douleurs, comme diagnostic différentiel, toutes les douleurs aiguës chirurgicales, quelles que soient. Ça peut être une occlusion, ça peut être une appendicite, ça peut être un enjeu colique, ça peut être une colique néphritique, une colique hépatique, etc. Et puis aussi, il y a le problème très dangereux au niveau utérin, qui est celui de la rupture utérine, mais ça, en général, c'est une situation en cours de travail.

C'est rare qu'on ait des ruptures utérines en dehors de la période du travail. Et enfin, il y a la douleur dans le cadre de l'infection, c'est-à-dire l'infection amniotique, parce que là aussi, peut-être qu'on vous a enseigné ça, qu'il y a de l'hyperesthésie cutanée. Ce sont des femmes qui sont infectées par leur utérus.

C'est une infection amniocoréale, c'est-à-dire que le liquide, le placenta et l'utérus sont infectés. Donc, il y a de la douleur et il y a de l'hyperesthésie cutanée. Bien évidemment, les autres signes vont s'accompagner, à savoir la fièvre, par exemple, à savoir l'hyperglycémie, la CRP-LV.

On peut aussi avoir des signes d'infection urinaire ou d'infection génitale. Et c'est ce qui va faire la confirmation diagnostique. Et enfin, à l'échographie, là encore, l'image échographique peut prêter à confusion avec tous les autres hématomes qu'on a déjà vus, comme ça peut être aussi les tumeurs placentaires.

Mais bien évidemment, les éléments cliniques sont la clé du diagnostic d'un hématome rétroplacentaire. C'est clair? OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une conduite à tenir en fonction de la gravité, justement, de l'hématome rétroplacentaire.

Donc, bien évidemment, la prise en charge urgente, c'est l'état hémodynamique. Et donc, on va prendre les deux voies veineuses de sécurité. On va sonder pour surveiller l'oligurie et chercher la protéinurie.

Et on a trois objectifs. Traiter l'état de choc et lutter contre l'hypovolémie. Évacuer l'utérus en urgence.

Et corriger les troubles des moustades s'ils existent. D'accord? Alors, bilan initial, ça va être le bilan pour tous les états de choc. Mais en plus, on va avoir tout ce qui concerne le bilan de la pré-éclampsie, bien évidemment.

Et l'évacuation de l'utérus, c'est-à-dire on va évacuer le fœtus et le placenta. Oui, c'est-à-dire qu'on va expulser le placenta qui est la cause des problèmes de coagulation par les médiateurs chimiques libérés par le placenta. Donc, là, il y a des situations cliniques différentes.

La première, quand vous avez un fœtus mort, on peut accepter l'accouchement par voie basse. Et donc, on fait la rupture large des membranes. Bien évidemment, cela dépend du bishop.

Vous vous rappelez du bishop? Est-ce que c'est un col ouvert? Parce que si c'est un col complètement fermé, on n'a pas d'accès à la poche des os, bien évidemment. Et là, on peut rentrer dans le mécanisme de déclenchement artificiel du travail, c'est-à-dire qu'on devrait faire une maturation du col et par la suite mettre le saintocyan. Ceci dit, tout cela va dépendre de la stabilité.

Si je commence mon déclenchement du travail, je garde la surveillance étroite de cette patiente parce que si maintenant elle n'a pas de troubles de coagulation, elle peut les avoir plus tard. Si maintenant elle n'est pas choquée, elle peut être choquée plus tard. Donc, je ne vais pas attendre même si elle est choquée ou même si elle a des troubles de coagulation, je vais arrêter le déclenchement et je vais faire l'extraction par vente.

Mais dans une situation stable où il n'y a pas d'état de choc, où il n'y a pas de forme grave, je peux déclencher le travail puisque c'est un mort fatale, c'est-à-dire donner la chance à cette patiente d'accoucher par vente à base pour ne pas infliger une césarienne pour un fœtus mort, chose qui est un peu difficile à vivre par la patiente. D'accord? Et bien sûr, si notre déclenchement échoue, on va passer à la césarienne. Bien évidemment, s'il y a un fœtus mort avec des troubles de la coagulation, et ça c'est le stade 3B de CHER, eh bien, on ne va pas attendre, on ne va pas déclencher, on va césariser d'emblée en faisant la correction au fur et à mesure du problème des mostazes.

Ensuite, si c'est un fœtus vivant et viable, ça veut dire qu'il n'est pas un grand prématuré, c'est-à-dire qu'on est à 29, 30, 31, 32 semaines, 34 semaines. D'accord? Là, bien évidemment, on va faire un sauvetage materno-fatal en faisant l'extraction par césarienne. Exception faite quand vous avez des patientes qui arrivent à dilatation complète avec une présentation engagée, bien évidemment, vous êtes obligés de les accoucher.

Sachez qu'en général, avec l'hématome rétro-placentaire, quand on fait un déclenchement du travail, ça se fait rapidement. Pourquoi? Parce que l'hématome, quand même, crée une pression intra-abdominale et donc ça va aider à pousser la présentation vers le bas. Et ceci, bien évidemment, si vous avez un bassin correct, un poids de bébé qui est correct, une présentation

correcte.

Il faut toujours garder ça en tête en obstétrique. On prend une décision par rapport à la pathologie médicale, mais il y a toujours les conditions obstétricales, c'est-à-dire le bassin, la triade, le mobile fatal, le moteur utérin et la filiale. Donc, c'est toujours ça qui conditionne la voie basse.

Si c'est favorable, ok, on y va, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un problème avec ça, même si médicalement, par rapport à l'HRP, on pourrait le faire, ce n'est pas possible. S'il y a un bassin chirurgical, s'il y a un utérus doublement cicatriciel, etc.

Ça, c'est aussi le travail du réanimateur qui accompagne toujours la gestion de l'HRP. On le fait toujours en équipe avec les réanimateurs. C'est le traitement du choc épovolumique.

On a compris que la déperdition sanguine n'est pas toujours en volume extériorisé. Donc, on doit faire une correction, même si le scénéma extériorisé est faible. Donc, on peut donner l'écule globulaire, les cristalloïdes, les électrolytes.

Bien évidemment, on devrait, en général, s'il y a un thrombopénie sévère, donner des plaquettes. S'il y a une CIVD, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit la PFC, le plasma frais congelé, soit les facteurs de coagulation. Et puis, prévenir et traiter l'hémorragie de la délivrance.

Donc, prévenir, c'est la délivrance dérigée, comme d'habitude. Et garder l'œil, ce n'est pas une patiente. On va prendre le temps de suturer doucement, de délivrer doucement.

On va devoir faire tout rapidement, suturer rapidement, pour arrêter ou diminuer la quantité de sang perdu. Parce que là encore, c'est un facteur aggravant. Plus le saignement se fait, plus la CIVD s'aggrave.

D'accord? Et dès qu'on sent que l'utérus n'est pas bien rétracté, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'inertie utérine, on doit traiter l'hémorragie de la délivrance par inertie. Notamment, le protocole existe dans l'hémorragie de la délivrance. Le trouble de la coagulation, il doit être précoce.

Et comme j'ai dit, il faut utiliser les produits nécessaires. Et il ne faut pas négliger le traitement de la prééclampsie, notamment les antihypertenseurs et le sulfate magnésium. Parce que ce sont des femmes qui risquent de faire l'eclampsie sur la table opératoire ou immédiatement au post-opératoire.

Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une patiente prééclampsique quand elle l'est. D'accord? Et si elle ne l'est pas traitée, si elle n'est pas sulfatée, elle risque de continuer son phénomène de prééclampsie. Elle peut faire l'eclampsie ou l'hématome sous capsuleur du foie par la suite.

Le pronostic dépend de la rapidité prise en charge. Sachez qu'on a une mortalité fatale très importante. Plus on tarde, plus ça ne va pas du tout.

Et la mortalité maternelle aussi peut survenir. Ce qui est préventif, c'est la prévention de la prééclampsie. Et là, ça a été établi qu'on devrait mettre en place l'asthmique.

Et ça, pour toutes les femmes qui ont un antécédent prééclampsique, un antécédent mort fatale, un antécédent d'HRP, une maladie de système, par exemple, une thrombophilie et aussi par l'administration du calcium. Minimum un gramme. Sinon, pour l'OMS, c'est jusqu'à deux grammes par jour.

Mais pour l'OMS, c'est l'apport quotidien, c'est-à-dire la nutrition plus la supplémentation. Ici, on sait que dans notre pays, quand même, on ne consomme pas beaucoup de calcium dans notre nutrition. On peut supplémenter en calcium de façon systématique.

Voilà. Donc, l'HRP, c'est une complication de la prééclampsie. C'est brutal, c'est imprévisible, diagnostique parfois évident, parfois difficile.

Et il a des complications graves. CIVD, insuffisance rénale, mort fatale, mort maternelle aussi. Et il faut une équipe multidisciplinaire.

D'accord? C'est clair? Vous avez des questions? Oui. Ah, il y a une nuance, c'est-à-dire que si vous êtes dans un centre où vous avez un échographe à côté, vous pouvez attendre pour votre toucher vaginal jusqu'à faire l'échographie pour situer le placenta. Et comme j'ai précisé tout à l'heure, j'ai dit que c'est un placenta prévia, non totalement recouvrant.

C'est-à-dire que vous l'avez vu à l'échographie. Vous avez vu qu'il y a un placenta prévia, mais qui n'est pas totalement recouvrant, c'est-à-dire qu'il est loin de l'orifice cervical. D'accord? Là, vous pouvez faire un toucher prudent et aller chercher la membrane si le col est ouvert, par exemple, et remplir la membrane, et ça va améliorer les choses.

La même chose pour l'HRP, c'est une métrorragie de trois intrimesses. C'est là où vous n'allez pas vous jeter sur la patiente pour faire le toucher vaginal, mais vous raisonnez. Vous voyez, si elle est en contracture, c'est probablement un HRP.

Si vous avez l'échographe à côté, vous allez vérifier l'emplacement du placenta. Et si vous avez un col ouvert, vous pouvez faire toucher votre rame à rupture artificielle de la membrane. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, supposons que vous n'avez pas d'échographe dans le centre où vous êtes, que vous avez une métrorragie de trois intrimesses.

Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes généraliste, vous travaillez dans un centre de santé où il y a une unité de maternité ou d'accouchement, et la sage-femme vous appelle. Docteur, voilà, j'ai une patiente qui saigne, elle est aux trois intrimesses. Oui, vous pouvez mettre un spéculum, mais le spéculum aussi va être traumatique si c'est un placenta totalement recouvert.

C'est dangereux, vous allez déclencher le saignement. Eh bien là, vous avez le droit de faire ce

qu'on appelle un toucher vaginal prudent. C'est-à-dire que vous y allez doucement et vous sentez.

Et je pense qu'on vous a décrit un signe qui s'appelle le signe du matelas. Non? C'est important. Le signe du matelas, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'entre tes doigts et la présentation qu'il y a un matelas.

Quelque chose qui est épais. Mais vous y allez doucement. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, si vous sentez le signe du matelas, c'est un placenta.

Après, il est totalement recouvert. Donc, vous allez dire à la sage-femme, c'est un transfert. Immédiatement.

Par contre, si vous faites vos touches vaginales doucement et que, par chance, cette patiente est en travail, vous pouvez trouver qu'elle est dilatée, elle est complète et elle accouche. Par exemple, même si c'est un placenta qui n'est pas totalement recouvert, parce qu'elle peut accoucher, les placentas ne sont pas totalement recouverts, n'est-ce pas? Tu continues à me suivre, Yac. Donc, le toucher vaginal, il est banni quand il est fait de façon imprudente.

Si vous avez l'échographie, vous faites votre échographie en premier et vous évaluez la situation du placenta. Si vous n'avez pas d'échographie et que vous êtes loin et que vous voulez décider. Parfois, en tout cas, elle a une dilatation à 3 cm, tu sens que les membranes sont là et que la présentation est là.

Donc, tu dis à la sage-femme, il n'y a pas de placenta totalement recouvert, vous pouvez y aller, vous pouvez l'accoucher. Tu vas faire la rame. Et quand tu vas faire la rame, elle va s'améliorer sur le plan saignement et cette femme peut accoucher.

D'accord? Donc, l'interdiction vient dans le sens d'attention quand vous avez un placenta prévia ou un saignement, ça peut être totalement recouvrant et il ne faut pas aller franc. Il faut aller doucement parce que si vous vous manipulez de façon brutale, vous décollez vous-même le placenta, ça fait saigner encore plus. Mais vous pouvez aller doucement pour sentir le signe du matelas ou pour évaluer.

Par exemple, tu as fait l'échographie et que c'est un placenta marginal, ce n'est pas totalement recouvrant et que la placenta contracte. Donc, tu feras ton toucher pour voir l'endossement de la dilatation et tu feras ta rupture artificielle à un moment donné. D'accord? Si tu gardes en tête que c'est interdit, tu ne pourras pas gérer une situation, même si tu fais l'échographie.

Parce que chaque fois que vous avez une patiente qui contracte, il faut faire un toucher. Mais il faut être doux. Ça se fait doucement.

On t'a déjà dit, si tu sens, est-ce que c'est une tête, est-ce que c'est un placenta, est-ce que c'est les membranes? C'est pour ça que je vous encourage à faire ça quand vous êtes au service et

quand vous êtes surtout en sixième année. Examinez avec conscience. Pour apprendre à sentir.

Si je dis que les membranes sont intactes, je vais refaire mon examen. Après, je vais sentir si les membranes sont intactes. Présentation engagée, non engagée, la poche des os, tout ça, il faut les apprendre maintenant.

Tu as compris l'interdiction? Le laisser comment? C'est-à-dire plusieurs jours, plusieurs semaines? Non. L'hématome rétroplacé, je l'écris nulle part, il n'y a aucune case de surveillance. Aucune case.

Quand on est sûr que c'est un HRP, on y va, quel que soit X, même s'il est prématuré, même s'il n'est pas viable, parce qu'il y a un risque maternel grave qui peut survenir après. Ce n'est pas comme une pré-eclampsie stabilisée. Pré-eclampsie sévère, stabilisée, il n'y a pas de complications graves, il n'y a pas de help syndrome.

Les complications sont des indications d'extraction. Il y a les critères de sévérité et les critères d'extraction. C'est-à-dire quand est-ce que je suis obligé de faire l'extraction, quel que soit le terme.

C'est l'après-eclampsie compliquée, compliquée, souffrance fatale, HRP, pré-eclampsie, dans des situations particulières, help syndrome, d'accord? Insuffisance rénale, OAP, non jugulée, etc. Donc l'HRP, c'est un critère d'extraction. On n'attend pas, on ne surveille pas.

Parce que ce qui va venir après, c'est des complications encore plus. On va aller non-retour. On ne va plus discuter.